

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

УДК 616-073.75:658.336.3

М.С.Садыков, К.М.Нурумбетов, Н.Г.Мусаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова

К вопросу об актуальных проблемах подготовки рентгенологов

Аннотация. Анализ причин ошибок и затруднений врачей, по данным направительных диагнозов показывает, что они имеют общий характер. Они связаны: недостаточной полнотой обследования- 26%, технически низким качеством полученных данных (рентгенограмм, томограмм, сканограмм)- 14%, неправильной трактовкой полученного результата-19%, незнанием симптомов и синдромов данного процесса -24%, неадекватным применением методов исследования – 17%.

Ключевые слова: Квалификация, рентгенолог, МРТ, качество, подготовка.

С целью уточнения вопросов требующих углубленного изучения при подготовке кадров лучевой диагностики, анализированы сопоставительные данные по направительным и окончательным диагнозам, на основе консультативной работы в КазНИИОиР, за последние 5 лет (2010-2015г.г.). Консультативная помощь оказана, в основном, амбулаторно (96%) обратившимся больным г. Алматы, Алматинской области и частично больным из южных регионов РК. Следовательно, работа в определенной мере, отражает состояние службы (подготовленности кадров) лучевой диагностики юга РК. За а указанный период проконсультированы 799 больных. Подавляющее большинство больных были направлены из поликлиник с предварительным диагнозом рак или саркома того или иного органа, системы; немало больных были направлены для исключения метастатического поражения того или иного органа. В общей сложности анализированы 1230 рентгенограмм, 552 томограмм, 630 КТ и 388 МРТ серий сканограмм, данные 377 УЗИ.

Наибольшее количество больных (247) направлено на консультацию с диагнозом рак легкого (112) или подозрение на рак легкого (135). При этом диагноз рака легкого подтвержден у 51 больного (центральный рак – 21, периферический рак - 30), по одному случаю диагностированы саркома легкого и сочетание рака легкого с туберкулезным процессом. На первом месте по частоте были воспалительные процессы в легких (79): подострая нижнедолевая пневмония (25), хроническая пневмония (17), плевропневмония (10), ограниченный пневмосклероз (10), среднедолевой синдром воспалительной природы (6), аллергические летучие инфильтраты (3), бронхоэктатическая болезнь (3), двусторонняя стафилококковая пневмония (2), левосторонний гидроторакс (1), грибковое поражение легких (2) [1].

Умногих больных (74) диагностированы туберкулезные процессы: очаговый туберкулез легких (34), инфильтративный туберкулез легких (19), подострый и хронический диссеминированный туберкулез легких (9), туберкулома (6), двусторонний очаговый туберкулез, осложненный плевритом (3), кавернозный туберкулез (2), ретенционная киста на почве эндобронхиального туберкулеза (1).

В некоторых случаях диагностированы доброкачественные опухоли легких: внутрибронхиальная аденома (3), гамартома (1), невринома (1), хондрома кольца трахеи (1). Диагностированы единичные случаи других процессов: множественные метастазы в легких (10), легочное проявление гемобластоза (2), метастаз в ребро (2), расслаивающая аневризма грудного отдела аорты (1), секвестрация легкого (1), релаксация купола диафрагмы (1), системное поражение лимфоузлов средостения (8) и даже легкие без патологических изменений (4), фиброзирующий альвеолит (1), инкрустация плевры (1), дермоидная киста средостения (1), тимомы (1), тимосаркома (1).

На втором месте по частоте консультации находились больные с патологией молочной железы (224 больных) [2]. Диагноз рака молочной железы у этой группы больных был установлен у 42 больных: узловые и диффузные формы рака (38), внутрипротоковый рак (3), папиллярный (1) и у двух больных отмечены лимфостаз верхней конечности на почве мастэктомии по поводу рака молочной железы. В остальных наблюдениях установлены диагнозы доброкачественных процессов: фиброзно-кистозная мастопатия (39), аденоматоз (24), фиброаденома (28), железисто-кистозная мастопатия (8), железистая мастопатия (14), железисто-фиброзная мастопатия (13), диффузный аденоз (9), инволютивные изменения (15), фиброзная мастопатия (12), внутрипротоковая папиллома (5), галлактоэктазия (5), внутрипротоковые кисты (5), цистоаденома (3).

Направление на консультацию при костной патологии (140) были двоякого рода: опухоль костей, исключить метастазы опухолей в кости [3]. Доброкачественная опухоль кости диагностирована у двух больных – ГКО верхней трети правой плечевой кости, остеомы локтевой кости. В остальных случаях это были метастатические процессы или дегенеративные изменения: метастазы в позвоночник, чаще поясничный отдел – 24, дегенеративные изменения (21) и грыжи (12) дисков, деформирующий остеохондроз пояснично-крестцового отделов позвоночника (42), вертебральная декальцинация (15), дегенеративные изменения тел позвонков (8), костно-хрящевой экзостоз (7), гетерогенное окостенение в ребре, в плечевой кости (5), Лоозерова зона перестройки в пальцах стоп (2), хондрит правого ребра (1), метастатическое поражение б/берцовой и таранной костей (1).

На четвертом месте по частоте диагностических затруднений у коллег стоит патология малого таза: заболевания яичников (49), матки (23), простаты (13) [4]. У консультированных больных с заболеваниями яичников установлены: киста яичника (23), рак яичника (9), сальпингофорит (9), аднексит (4), многокамерная цистоаденома (3) и правосторонний tuboовариальный абсцесс (1). При патологии матки диагностированы: рак эндометрия

(2), рак канала шейки матки (1), рецидив в культе шейки матки (1), рецидив в Дугласовом пространстве (1), миома матки (17), перфорация мукозы при гистерографии (1).

При патологии простаты выявлены – рак простаты (4), в одном случае из них диагностировано прорастание опухоли в мочевой пузырь, прямую кишку и наличие метастазов в лимфатических узлах таза; аденома простаты (4), у одного из них диагностированы – мочекаменная болезнь, камни мочевого пузыря, поликистоз обеих почек, простатит (2), гиперплазия простаты (3).

Группа больных была прислана на консультацию с целью исключить или подтвердить наличие метастатических поражений при выявленном первичном очаге (19). Анализ данных подтвердил наличие метастазов: в мозжечок, легкие и печень при внеорганных опухолях таза с прорастанием в мочевой пузырь (1); в кости позвонков (грудных – 3, поясничных – 1), лопатку (1), ключицу (1), головку плечевой кости (1), кости таза (1), тело грудины (1) при раке простаты или раке молочной железы. Выявлены органые метастазы: в легкие, лимфоузлы средостения, в плевру, печень, поджелудочную железу, в почку. Причинами были – рак яичника, рак простаты, рак молочной железы, рак желудка.

На основании анализа данных при патологии средостения установлены следующие диагнозы: нейросаркома заднего средостения (3), киста (2), «ныряющий» (1) и загрудинный зоб (2), энтерогенная киста (1), аневризма аорты (1), саркома мягких тканей средостения (1), атеросклероз аорты (1), расширение брахицефальных сосудов (1).

Консультированы рентгенологические (болюсная КТ) и МРТ данные больных с патологией паренхиматозных органов (40): поджелудочная железа (15) – рак железы (7), псевдотуморозный панкреатит (5), киста головки поджелудочной железы (3); печень – гемангиома (1), гематома в ложе оперированного желчного пузыря (1), метастазы (6), киста (3), гепатоспленомегалия (1); надпочечник – аденома (1).

Рентгенологические и МРТ данные больных с патологией головы и шеи позволили установить следующие диагнозы: астроцитомы лобно-височной области справа (1), метастазы в мозжечок (1), метастазы в другие структуры мозга (5), продолженный рост рака носоглотки в область турецкого седла (1), гайморит (2), хронический отит (1), узловой зоб (1), воспаление гортани (1), рак глотки и шейного отдела пищевода (1). Единичные случаи консультации приходится на патологию кожи, мягких тканей, плевры. При этом диагностированы: доброкачественная опухоль мягких тканей левой голени (1), отсутствие прорастания кости при меланоме кожи правой стопы (1), узловатая форма мезотелиомы плевры (5), осумкованный плеврит (1), агрессивный фиброматоз передней брюшной стенки (1).

Диагностические затруднения при патологии желудочно-кишечного тракта низки, эти больные редко попадают на консультацию. Причина в возможности и необходимости фиброэндоскопических исследований при наличии сомнений в диагнозе патологии желудочно-кишечного тракта. На стадии эндоскопических исследований окончательно уточняются диагнозы [5]. Из обратившихся диагностированы: рак желудка (2), гастрит (1), рак толстого кишечника, спастический колит и баугинит (1), что составили незначительную долю нашей работы.

Совпадение направительного с окончательным диагнозом отмечено: при патологии легких – в 31,6%, при патологии молочных желез – в 26,8%, при патологии костей – в 24,3%, при патологии органов малого таза – в 27,1%.

Анализ причин ошибок и затруднений врачей, по данным направительных диагнозов, показывает, что они имеют общий характер. Они связаны: недостаточной полнотой обследования – 26%, технически низким качеством полученных данных (рентгенограмм, томограмм, сканограмм) – 14%, неправильной трактовкой полученного результата – 19%, незнанием симптомов и синдромов данного процесса – 24%, неадекватным применением методов исследования – 17%.

Выводы:

1. Наибольшее количество диагностических консультативных случаев

относятся к больным с патологией легких, молочной железы, костей и органов малого таза.

2. Следовательно, усовершенствование врачей-рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, МРТ-специалистов следует проводить по онкопатологии вышеуказанных локализаций.

3. Отмечается слабое знание врачами вопросов дифференциальной диагностики опухоли легких, легочного туберкулеза и воспалительных заболеваний легких. Неоправданно увлечение КТ и МРТ легких без предварительного полноценного рентгенологического исследования. КТ и МРТ легких осуществляется трафаретно – стандартно, вместо исследования «зон интереса».

4. Отсутствие подготовленных маммологов, наличие малоквалифицированных рентгеномаммологов порождают очень частую гипер- и гиподиагностику при наличии патологии в молочных железах. Необходима срочная переподготовка рентгеномаммологов.

5. Диагностические затруднения при остеонкологии связаны с плохим знанием классической рентгеноостеологии (которому альтернативы нет!) и увлечением КТ, МРТ. Эти исследования нужны при костной патологии для решения ограниченных задач.

6. Исследования патологии органов малого таза должны начинаться с УЗИ и заканчиваться МРТ.

Список литературы

1. Власов П.В. Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. - М.: Издательский дом Видар, 2006. - 312 с.

2. Сандыбаев Д.Р., Адылханов Т.А., Мусинов Д.Р., Муканов К.Т. Эходоплерографические признаки рака молочной железы // Онкология и радиология Казахстана. - 2005. - №3 (12). - С.28-31.

3. Рентгенодиагностика первичных и опухолеподобных заболеваний позвоночника / Под ред. Миронова С.П. - М., 2004.

4. Линденбратен Л.Д., И.П. Корольюк // Медицинская радиология. - М- 2000.

5. Михайлов М.К., Тухбатуллин М.Г. Комплексная лучевая диагностика новообразований желудка. - Казань: Фэн, 2001.

Тұжырым

М.С.Садықов, К.М.Нурымбетов, Н.Г.Мусаев

Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты

С.Д. Асфендияров атындағы Қазақтың Ұлттық медицина университеті

Summary

M.S.Sadykov, K. M. Nyrymbetov, N. G. Mysaev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Kazakh National Medical University after S.D.Asfendiyarova**Рентгенолог мамандарды дайындаудағы өзекті мәселелер**

Соңғы 5 жылда Қазақ Онкология және Радиология Ғылыми Зерттеу Институтында рентгенологиялық кеңестен өткен 799 науқастың, жіберілген диагнозы мен ең соңғы диагноздарын салыстыра отырып, рентгенолог мамандығын дайындауда қандай маңызды мәселелерге көңіл бөлу керектігі зерттелген. Жалпы анықтауда 1230 рентгенограмма, 552 томограмма, 630 КТ және 388 МРТ сериялы сканограмма, 377 науқасқа ультрадыбысты зерттеу жасалынған.

Жіберілген диагноздың қателігін зерттеу негізінде төмендегідей қателіктер тіркелген: толық зерттеуден өтпегендіктен – 26%, төмен техникалық сапамен (рентгенограмма, томограмма, сканограмма) – 14%, алынған нәтижесін дұрыс емес анықтаған – 19%, синдром мен симптомдарды білмегендіктен жіберген қатесі 24%, Адекватты емес (өзгеше, басқа) әдістерді қолданудан жіберген қатесі – 17%.

Түйінді сөздер: мамандық, рентгенолог, МРТ, сапа, дайындау.

To the question about the issues of the day of training of radiology's

With the purpose of clarification of questions requiring a deep study at training of personnel's of radial diagnostics, analyses comparable information on direct and final diagnoses, on the basis of advise work for the last 5 years. For indicated period 799 are advised patients. In general complication analysis 1230 sciagrams, 552 tomogram, 630 KT of series of skanogram and 388 MRT of series of skanogram, information is 377 ULTRASONIC.

The analysis of reasons of errors and difficulties of doctors, from data of direct diagnoses, shows that they have general character. They are constrained: by insufficient plenitude of inspections- 26%, by low quality of findings (sciagrams, tomogram, skanogram)- 14%, by irregulars interpretation of got rezul'tata-19%, ignorance's symptoms and syndromes of this process -24%, by inadequate application of research methods – 17%.

Keywords: qualification, radiologist, MRI, quality, preparation.